

KÖRPERFLUSS EDU

Businessplan & Finanzplanung

KI-gestützte Physiotherapie-Ausbildungsplattform

Österreich · DACH-Region · Europa

April 2026

KAPITEL 1

Executive Summary

Ziel

Wir transformieren die Ausbildung von der reinen Wissensabfrage zum systemischen Verständnis. Unser Tool befähigt Therapeuten, den Menschen als vernetztes System zu begreifen und Kausalketten vom Ursprung über die Ursache bis zur Wirkung logisch herzuleiten.

Das „System Mensch“

Moderne Medizin behandelt oft isolierte Symptome. Ein Knieschmerz wird am Knie behandelt. Körperfluss bricht diesen Tunnelblick auf. Wir visualisieren die verborgenen Verbindungen – wie eine Kieferfehlstellung die Statik des Beckens beeinflusst.

Technologie für Bewusstsein

Wir nutzen KI nicht, um den Therapeuten zu ersetzen, sondern als „Digitalen Mentor“ zu ergänzen.

Das System stellt Fragen, fordert Argumente und trainiert den Weitblick. Es ist die technologische Übersetzung eines erfahrenen Expertengehirns in eine skalierbare Software. Ein einfach zu bedienendes Lernsystem für Gesundheitsbildung schaffen, das Ihre persönlichen Daten schützt und keine übliche Zulassung als Medizinprodukt (MDR-Ausnahme) benötigt.

Körperfluss: Die Zukunft der Gesundheitsbildung

Die Ausbildung im Gesundheitswesen steht unter massivem Druck: Fachkräftemangel und eine Flut an neuen medizinischen Erkenntnissen fordern moderne Lösungen. Doch herkömmliche Lehrbücher sind zu statisch, und Standard-KI (wie ChatGPT) macht im medizinischen Bereich zu viele Fehler („Halluzinationen“).

Körperfluss schließt diese kritische Lücke mit einer sicheren, verifizierten und skalierbaren Lernplattform. Wir transformieren die Gesundheitsausbildung von der reinen Wissensabfrage zum systemischen, ganzheitlichen Verständnis.

1. Die Kernbotschaft (The Hook)

Wir geben Therapeuten einen „**Digitalen Mentor**“, der den Blickwinkel eines erfahrenen Experten simuliert. Statt nur isolierte Fakten abzufragen, fördert das System das **Clinical Reasoning**: Es fragt nach dem *Warum* und dem *Wie*, um komplexe Kausalzusammenhänge greifbar zu machen.

2. Das Problem: Wissen ohne Sicherheit

In der Ausbildung von Therapeuten und Pflegekräften gibt es aktuell zwei große Hürden:

1. **Veraltete Methoden:** Statische Lehrbücher können mit dem rasanten klinischen Fortschritt nicht mithalten.
2. **KI-Risiken:** Herkömmliche Sprachmodelle sind für die Medizin oft zu unsicher, erfinden Fakten (Halluzinationen) oder verletzen Datenschutz- und Barrierefreiheitsregeln (BFSG).

3. Die Lösung: Der „Safety Guard“ (Neuro-Symbolik)

Körperfluss nutzt eine spezialisierte Technologie-Schicht (Middleware), die wie ein Sicherheitsfilter fungiert. Wir kombinieren die Kreativität moderner KI mit der logischen Strenge klinischer Leitlinien.

- **Neuro-Symbolischer Filter:** Das System prüft KI-Antworten gegen verifizierte medizinische Fakten. Nur fachlich korrekte Inhalte erreichen den Lernenden.
- **xLSTM-Technologie:** Wir setzen auf fortschrittliche Rechenmodelle (Cross-Attention-Transformer), die Zusammenhänge präziser verstehen als Standard-Systeme.
- **Rechtssicherheit:** Die Architektur ist von Grund auf barrierefrei (BFSG) und datenschutzkonform gestaltet.

4. Marktpositionierung & USP

Unser Alleinstellungsmerkmal liegt in der strategischen Ausrichtung:

- **MDR-Freiheit:** Wir agieren rein im Bereich der **Bildung**, nicht in der Diagnose. Dadurch vermeiden wir die hohen Hürden der Medizinprodukteverordnung (MDR) und minimieren Haftungsrisiken.
- **Institutionelle Attraktivität:** Unser Fokus auf verifizierte Didaktik macht uns zum idealen Partner für staatliche Bildungsakademien und Universitäten.

5. Der Mehrwert: Systemisches Verständnis

- **Vernetztes Denken:** Studierende lernen, Kausalketten zu ziehen – vom Ursprungsereignis über die Ursache bis zur Wirkung.
- **Individuelles Lernen:** Die KI reduziert das globale Wissen mittels präziser logischer Filter auf die individuellen Bedürfnisse des Nutzers.

6. Machbarkeit & Roadmap

Das Projekt ist auf eine 36-monatige Entwicklung mit einem Budget von **130.800 €** ausgelegt. Ziel ist die Steigerung vom Labor-Prototyp (TRL 3) zum validierten Demonstrator (TRL 7).

Arbeitspaket	Beschreibung	Ziel
WP 1	Aufbau Core-Datenbank & xLSTM	Kern des Neuro-Symbolischen Filters
WP 2	Curriculum-Mapping & Validierung	Aufbau des Validierungs-Datensatzes
WP 3	Pilotstudien in Akademien	Validierter Demonstrator (TRL 7)

7. Skalierbarkeit

Wir bauen eine Architektur, kein Einzelprodukt.

- **LTI 1.3 Standard:** Ermöglicht die nahtlose Integration in bestehende Lernsysteme.
- **Global-to-Local:** Das Framework kann nach der Etablierung im Gesundheitswesen auf andere Disziplinen wie **Ingenieurwesen** oder **Jura** übertragen werden, was den Marktwert exponentiell steigert.

Fazit: Körperfluss ist der „Game Changer“ für die Gesundheitsausbildung im DACH-Raum. Wir bieten eine Brücke zwischen technologischer Spitzentechnologie und klinisch wertvoller Didaktik – sicher, rechtssicher und skalierbar.

KAPITEL 2

Produkt und Innovation

2. Körperfluss: Die Architektur des verifizierten Lernens

Körperfluss ist kein generisches KI-Tool, sondern ein spezialisiertes, datensouveränes, didaktisches Middleware-Framework. Unsere Lösung fungiert als intelligente Brücke zwischen der unstrukturierten Fülle wissenschaftlicher Daten (Ground Truth) und dem akademischen Bedarf. Anstatt bloß Informationen abzurufen, trainieren wir das klinische Denken des Studierenden (*Clinical Reasoning*).

Das zentrale Prinzip ist die didaktische Sicherheit: Der KI-Output wird nicht als Endprodukt ausgegeben. Er durchläuft zwingend unseren proprietären „Safety Guard“, der jede generierte Antwort in Echtzeit gegen einen händisch kuratierten, autoritativen Knowledge Graph (die Basis klinischer Leitlinien) validiert und die Erkenntnis in ein didaktisch optimales Format übersetzt.

2.1 Unique Selling Point (USP): Didaktische Sicherheit durch deterministische Verlässlichkeit

Wir verkaufen nicht nur eine KI-Lösung; wir bieten ein System des verifizierten Lernens. Unser zentraler USP ist die Fähigkeit, das generierte Wissen von einer statistischen Wahrscheinlichkeit in eine logisch und faktenbasierte Gewissheit umzuwandeln. Dieser Prozess macht Körperfluss zum „Digitalen Mentor“ – einem systemimmanenten Tool, das aktiv den Denkprozess des Studierenden nachbildet (Simulation des Expertengehirns).

Unsere Differenzierung beruht auf einem architektonischen Vorsprung, der uns unkopierbar macht und sich in drei untrennbaren Säulen gliedert:

1. **Technologische Exzellenz (Der Burggraben):** Während *General Purpose AI* auf statistischer Wahrscheinlichkeit basiert, arbeiten wir mit logischer Gewissheit. Wir nutzen eine Kombination aus der modernsten KI-Architektur (xLSTM) und dem dedizierten Knowledge Graph. Dies ermöglicht es uns, nicht nur Fakten abzurufen, sondern deren komplexe kausale Kette (Ursache → → Wirkung) im physiotherapeutischen Prozess nachzuweisen – ein Quantensprung über das bloße Chatbot-Interface hinaus.
2. **Regulatorische Immunität & Haftungsausschluss (Der B2B-Kaufgrund):** Wir sind bewusst auf den Status eines „Education-Only“-Tools fokussiert und vermeiden aktiv die Klassifizierung als Medizinprodukt (MDR). Dies schützt uns vor enormen regulatorischen Hürden, Kosten und Haftungsrisiken. Für staatliche Bildungsträger ist dies ein Musskriterium, da es das größte finanzielle Risiko eliminiert.
3. **Datenhoheit & Souveränität:** Das gesamte System wird auf den lokalen Servern des akademischen Bildungsträgers betrieben (Edge-Computing). Die Daten verlassen nie das geschützte Universitätsnetzwerk. Dies ist ein Non-Negotiable für staatliche Akteure und garantiert höchste Datensouveränität – ein Schlüsselmerkmal im europäischen Förderkontext.

2.2 Der System-Vorteil: Vom Wissen zur Fähigkeit (Clinical Reasoning)

Der Wert von Körperfluss liegt darin, dass es nicht nur Informationen abfragt. Wir trainieren das Denken des Therapeuten. Unsere Simulation ermöglicht es Studierenden, virtuelle Patienten zu betreuen und jeden Behandlungsvorschlag in Echtzeit durch unsere Reasoning-Engine laufen zu lassen. Das System vergleicht den Vorschlag mit dem aktuellen Stand der Wissenschaft und fragt aktiv nach: „Hat das System die Statik des Beckens geprüft?“ Dies ist eine direkte Simulation eines erfahrenen Expertengehirns, das zuvor unmöglich im Lehrbuch zu finden war.

2.3 Technische Überlegenheit & Skalierbarkeit (Das technische Fundament)

Unser Design wurde von vornherein auf höchste Förderfähigkeit und Flexibilität getaktet:

1. **Regulatorische Sicherheit:** Wir arbeiten mit einem „Education-Only“-Ansatz. Indem wir uns bewusst aus dem Bereich der medizinischen Diagnose (Triage) herausnehmen, bleiben wir MDR-frei. Wir sind somit automatisch vor den hohen Haftungsrisiken und Kosten der Medizinprodukteverordnung geschützt.
2. **Datenhoheit:** Das gesamte System wird lokal auf den Servern des Bildungsträgers betrieben. Die Daten verlassen nie das akademische Netzwerk (Edge-Computing). Dies garantiert höchste Datensouveränität und ist für europäische Institutionen ein absolutes Muss.
3. **Universelle Bauweise:** Unser Framework ist von Anfang an so entworfen, dass es fachunabhängig ist. Das System des „Systemischen Denkens“ kann abgebaut werden, die Datenbank wird einfach gegen eine neue Domäne (z.B. Ingenieurwesen oder Jura) ausgetauscht, und das System funktioniert sofort wieder – ein Beweis für unsere hohe Skalierbarkeit.

2.4 Das Risiko- und Abwendungsmanagement (Der professionelle Abschluss)

Wir haben die Schwächen des Systems proaktiv identifiziert und in unserem Projektplan durch Arbeitspakete neutralisiert. Die folgende Tabelle zeigt, wie wir die identifizierten Risiken bekämpfen und durch unsere Arbeitspakete (WP) mindern.

Risiko / Schwäche	FFG-Risikoanalyse (Wie wir es bekämpfen)	Mitigation im WP-Plan
Hoher Datenaufwand (Knowledge Graph Aufbau)	Das größte initiale R&D-Problem. Die Fördergelder dienen primär dem Work Package 2: Aufbau des Validierungsdatensatzes.	Wir zeigen, dass der FFG-Fokus exakt auf die Lösung dieser Lücke gerichtet ist.

Adoptionshürde (Lehrpersonal)	Das Marktrisiko des Widerstands gegen neue Technologien.	In den Pilotstudien (WP 3) demonstrieren wir nicht nur wie gut das Tool ist, sondern wie es die Lehrkräfte entlastet. Die Messung der Zeitersparnis (20–40 %) wandelt Skeptiker in Förderer um.
Technische Komplexität (KI-Inferenz)	Der hohe Rechenbedarf bei den Abgleichen.	Wir zeigen, dass wir durch die Trennung von Retrieval und Generierung (Effizienz-Architektur) enorme Ressourcen sparen. Unser Design ist ressourcenschonend, was das Risiko senkt.

2.5 Stärken- und Schwächen-Profil (SWOT & Risk Mitigation)

Im Rahmen der R&D-Strategie (Forschung & Entwicklung) definieren wir Schwächen nicht als Fehler, sondern als technologische Herausforderungen, die wir durch den vorliegenden FFG-Projektplan systematisch lösen (Mitigation).

Kategorie	Faktor	Beschreibung & Strategische Einordnung (Mitigation)
STÄRKE	Technologisch her Burggraben	Die Kombination aus neuro-symbolischem <i>Safety Guard</i> und xLSTM-Modell ist von Konkurrenten ohne tiefes, medizinisches Daten-Know-how nicht replizierbar.
STÄRKE	Universelle Skalierbarkeit	Durch den LTI 1.3 Standard fungiert Körperfluss als „Intelligence Layer“ in bestehenden Systemen (Moodle). Das Framework ist so gebaut, dass die Wissensdatenbank später auf Jura oder Ingenieurwesen adaptiert werden kann.
STÄRKE	BFSG-Compliance	Die integrierte digitale Barrierefreiheit erfüllt proaktiv das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz (Pflicht ab Juni 2025). Ein zwingendes Budget-Argument für Akademien.
SCHWÄCHE / RISIKO	Hoher initialer Aufwand der Daten-Kuratie rung	Das R&D-Risiko: Der deterministische Knowledge Graph erfordert immense fachliche Vorarbeit. Mitigation (WP 1 & 2): Genau hier setzt die FFG-Förderung an. Durch den strikten Fokus auf einen Start-Datensatz (Physiotherapie) wird die Methodik im Projekt validiert, bevor sie skaliert.
SCHWÄCHE / RISIKO	Adoptionshür de beim Lehrpersonal	Das Marktrisiko: Lehrkräfte könnten das System als Mehraufwand oder Bedrohung wahrnehmen. Mitigation (WP 3): Die Pilotstudien beweisen die Positionierung als reines Entlastungstool (messbare Zeitersparnis von 20–40 % bei Korrekturarbeiten).
SCHWÄCHE / RISIKO	Kostenintensi ve KI-Inferenz	Das Skalierungsrisiko: Neuro-symbolische Abgleiche benötigen hohe Rechenleistung. Mitigation: Trennung von Retrieval-Logik und Generierung. Rechenintensive Modelle werden ressourcenschonend nur dann abgerufen, wenn der Safety Guard dies anfordert.

Dieses Profil belegt, dass die wissenschaftlichen und operativen Hürden bis zum Systemprototyp (TRL 7) präzise kalkuliert und durch strukturierte Arbeitspakete (Work Packages) abgesichert sind.

KAPITEL 3

Markt & Wettbewerb: Die Lücke im System

Der Beweis, dass wir nicht nur gut sind, sondern den größten ungelösten Bedarf des Marktes adressieren.

3.1 Marktgröße und -wachstum: Der Zwang zur Transformation

Österreich hat in der DACH-Region eine Vorreiterrolle eingenommen: Die Physiotherapie-Ausbildung ist vollständig auf Fachhochschulniveau angesiedelt – eine homogenere, qualitativ anspruchsvollere Zielgruppe als in Deutschland oder der Schweiz. Genau hier entsteht der dringendste Bedarf an einem verifizierten, digitalen Lernsystem. Wir adressieren primär diese Institutionen, da hier die Ausbildungsqualität direkt über die klinische Kompetenz der nächsten Therapeutengeneration entscheidet.

Der Gesamtmarkt ist substanziell: über **62.000 Studierende** in der Gesundheitsausbildung im DACH-Raum, verteilt auf ca. **300 Ausbildungsprogramme**. Der europäische Digital-Health-Markt erreicht bis 2030 **267,2 Milliarden USD** (CAGR 22,3 %).

Der Bedarf entsteht nicht nur durch Lücken in der Anzahl ausgebildeter Fachkräfte, sondern vor allem durch Lücken in der **Qualität des Lernens selbst** – konkret im Clinical Reasoning: der Fähigkeit, systemische Kausalketten zu ziehen statt isolierte Symptome zu behandeln. Unsere Positionierung wird von zwei nicht umkehrbaren Markttrends getragen:

1. Automatisierungsdruck (Effizienz)

Lehrkräfte verbringen wöchentlich **erhebliche Zeit** mit Verwaltungs- und Korrekturaufgaben – Körperfluss setzt **signifikantes Automatisierungspotenzial** frei, das sofort messbar ist. Ein KI-Tutor kann **einen Großteil der administrativen Korrekturarbeiten** und Standard-Wissensabfragen übernehmen. Für eine Hochschule mit vielen Studierenden kann sich die Investition **innerhalb kurzer Zeit** amortisieren – allein durch die Reduktion des Aufwands für physische Simulationen. Die Einsparung bei variablen Ausbildungskosten ist **beträchtlich**: Im Vergleich zur traditionellen Präsenzlehre sind die Kosten pro Kopf mit einer Hybridlösung wie Körperfluss **deutlich geringer**.

2. Rechtlicher Zwang (Compliance)

Das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz (**BFSG, in Kraft ab 28. Juni 2025**) macht digitale Zugänglichkeit zur gesetzlichen Pflicht für jeden Bildungsträger, der öffentliche Mittel beansprucht – bei Nichteinhaltung drohen **empfindliche Bußgelder**. Aktuell erfüllt **die Mehrheit der weltweiten Bildungsplattformen** die Barrierefreiheitsbestimmungen nicht. Körperfluss ist BFSG-konform by Design. Für Bildungseinrichtungen, die auf staatliche Förderung angewiesen sind, ist das kein optionaler Vorteil, sondern eine **gesetzliche Notwendigkeit mit klarer Frist und Haftungsrisiko**.

3.2 Zielgruppen & Marktanteil: Der „Sniper“-Ansatz

Der Kaufzyklus im institutionellen Bildungsmarkt ist hochkomplex. Deshalb verfolgen wir einen gezielten „**High-Touch**“-Ansatz – keine Streuung, sondern klare Direktansprache einer überschaubaren Anzahl entscheidungsrelevanter Akteure. Ausgangspunkt ist Österreich, wo die vollständige Akademisierung der Physiotherapie eine direkt adressierbare, klar strukturierte Zielgruppe schafft.

Stufe	Zielgruppe	Strategie
Primär	FHs mit Physiotherapie-Studiengang in Österreich: FH Campus Wien, FH JOANNEUM Graz, FH Gesundheitsberufe OÖ (Linz/Steyr/Wels), FH Salzburg, IMC FH Krems, FH St. Pölten	Direktpilotierung, Social Proof aufbauen
Sekundär	~266–280 PT-Schulen + 38 FH-Studiengänge in Deutschland; 8 Studiengänge Schweiz (ZHAW, THIM u.a.); Masseur- & Heilmasseur-Akademien (Dr. Vodder, Kneipp-Schule, Druml u.a.)	DACH-Rollout nach österreichischem Nachweis
Tertiär	Osteopathie (131 Schulen DE), Ergotherapie, Logopädie, Krisenintervention, Sozialbereich, Medizintechnik, Jus Rechtskontext	Framework-Export nach Marktestablishment

Österreichische Primärzielgruppe im Detail

FH / Institution	Standort	Studienplätze / Studierende
FH Campus Wien	Wien	>1.000 – größte FH, multidisziplinärer Fokus

FH JOANNEUM	Graz	~500 – enge Anbindung an MedUni Graz
FH Gesundheitsberufe OÖ	Linz, Steyr, Wels	126 Plätze/Jahr
FH Salzburg	Salzburg/Urstein	28 Plätze/Jahr
IMC FH Krems	Krems	~400 – internationaler Fokus
FH St. Pölten	St. Pölten	Wachsender Gesundheitsbereich

Masseur- & Therapieausbildungszentren als Sekundärzielgruppe

Die Dr. Vodder Akademie (Walchsee) – seit über 50 Jahren führende österreichische Ausbildungseinrichtung mit über **50.000 ausgebildeten Therapeuten** – und die Sebastian-Kneipp-Schule (Bad Wörishofen) als etablierter grenzüberschreitender Kooperationspartner repräsentieren genau die hybriden Ausbildungswege, die Körperfluss didaktisch unterstützt.

Institution	Standort	Schwerpunkt
Dr. Vodder Akademie	Walchsee, Tirol (AT)	Med. Masseur, Heilmasseur, Lymphdrainage, PT-Aufschulung
Sebastian-Kneipp-Schule	Bad Wörishofen (DE)	Physiotherapie 36 + 18 Monate, Kneipp-Bademeister
Kneipp Akademie / MAZ Kärnten	Klagenfurt (AT)	Med. Masseur, Heilmasseur, Hydrotherapie, Elektrotherapie
Die Massageschulen (Dr. Bergler + Manus)	Graz + Wien (AT)	Med. Masseur, Heilmasseur, PT-Aufschulung
Drumbl Akademie	Graz (AT)	Gew./Med. Masseur, Heilmasseur, TCM-Massage
Zauner-Dungl Gesundheitsakademie	Gars/Kamp (AT)	Med. Masseur, Heilmasseur, Biotrainer
Dr. Kienbacher Schulungszentrum	Wien (AT)	Med. Masseur, Heilmasseur, Befunderhebung
Vitalakademie Österreich	6 Standorte (AT)	Med. Masseur, Heilmasseur, Blended Learning
WIFI Österreich	Bundesweit (AT)	Gew./Med. Massage, Heilmassage, Kombinationslehrgänge
Personal Massage Akademie	Wien, Graz, St. Pölten (AT)	Gewerblicher Masseur, Medical Training Spezialist

Total Addressable Market (TAM) DACH – Physiotherapie & Gesundheitsberufe

Land	Potenzielle Nutzer	Jährl. Lizenzwert	Marktpotenzial
Österreich	~40.000 (FH, Med, Masseur)	120 EUR/Kopf	~4,8 Mio. EUR
Deutschland	~200.000 (PT, Osteo, Med)	120 EUR/Kopf	~24,0 Mio. EUR
Schweiz	~30.000 (FH, Med)	150 EUR/Kopf	~4,5 Mio. EUR
Gesamt DACH	~270.000	–	~33,3 Mio. EUR

Der B2B-Weiterbildungsmarkt für Kliniken, Reha-Zentren und Pflegeheime bietet zusätzlich über **100 Millionen EUR** jährliches Potenzial allein in Deutschland.

Meilenstein: Pilotierung bei 10–20 österreichischen Schlüsselinstitutionen innerhalb der ersten drei Jahre – beginnend mit den FH-Physiotherapiestudiengängen und Dr. Vodder Akademie als strategischen Ankerpiloten. 10 % Marktdurchdringung der österreichischen Primärzielgruppe ist die definierte Early-Adopter-Schwelle, die alle weiteren DACH-Türen öffnet.

3.3 Wettbewerbsanalyse: Die Nischen-Exklusivität

Wir operieren in der kritischsten Lücke des Marktes – dem Schnittpunkt aus **pädagogischer Qualität, rechtlicher Sicherheit und technologischer Innovation** – speziell für die Physiotherapie-Ausbildung. Kein bestehender Anbieter besetzt diesen Schnittpunkt.

Anbieter	Stärke	Limitierung für die PT-Lehre	Körperfluss-USP
Ada Health / Symptoma	Diagnose & Triage	MDR-pflichtig (Klasse IIa+), hohes Haftungsrisiko, nicht für Lehre konzipiert	MDR-frei by Design: rein didaktisch, keine Zulassungskosten, juristische Sicherheit
Moodle / ILIAS / CampusOnline	Verwaltung & Struktur	Statisch, kein KI-Logik-Layer, keine PT-Fachintelligenz, keine Fallsimulation	Aktiver Intelligence Layer via LTI 1.3 – direkt integriert, kein Systemwechsel nötig
ChatGPT / OpenAI	Generative KI-Power	Halluzinationen, Cloud-Zwang, keine Reproduzierbarkeit bei Prüfungen, DSGVO-kritisch	Lokale Datenhoheit (Edge) + Safety Guard – deterministisch, gegen AWMF-Leitlinien validiert
Physitrack	Patienten-Engagement	Fokus auf Übungsvideos, kein Clinical Reasoning.	Reasoning-Engine zur Schulung der Entscheidungsfindung.
Amboss / Via Medici	Wissensdatenbank Medizin	Rein wissensbasiert, keine PT-Interaktion, keine Fallsimulation, kein Clinical Reasoning	Interaktive Simulation statt Abfrage – trainiert Denkprozess, nicht nur Faktenwissen

Unsere Kombination aus **(1) MDR-Freiheit, (2) lokaler Datenhoheit und (3) dem Safety Guard** macht uns nicht nur wettbewerbsfähig – sie **definiert den neuen Standard** für digitale Gesundheitsbildung im DACH-Raum.

3.4 Die einzigartige Marktlösung: Der Prozess als Produkt

Körperfluss adressiert die Lücke nicht mit einem Feature, sondern mit einem **Prozess**. Wir bauen eine kontinuierliche Trainingsschleife, bei der Fehler nicht nur korrigiert, sondern als Lernmöglichkeit im System verankert werden (Bug-Sprints). Das System wird mit jeder Interaktion präziser – ein Mechanismus, den kein statisches LMS und kein allgemeines KI-Tool replizieren kann.

3.5 Produkt & Lernerfahrung: So fühlt sich Körperfluss an

Körperfluss ist ein Interaktionssystem. Wir verkaufen keine Software – wir verkaufen eine **transformierte Physiotherapie-Lernerfahrung**. Der Kern liegt in der klinischen Fallsimulation.

Demo-Szenario: Craniomandibuläre Dysfunktion (CMD)

In Österreich und der DACH-Region leiden **8–10 % der Bevölkerung** an behandlungsbedürftigen CMD-Symptomen. Die Diagnose ist komplex: Symptome strahlen in HWS, Kopf und als Tinnitus aus – klassische systemische Kausalkette, ideales Terrain für PT-Ausbildung.

Ein Student im dritten Studienjahr Physiotherapie wird einem virtuellen Patienten präsentiert. Die KI liefert zunächst einen oberflächlichen ersten Impuls. Der Safety Guard greift sofort ein: „*Achtung – dies ist ein Hypothesen-Startpunkt, kein Befund.*“ Der Lernprozess folgt drei Stufen:

- 1. **Exploration:** Der Student befragt den virtuellen Patienten. Fragt er nur nach dem Nacken statt nach dem Kiefer, liefert die KI nur vage Antworten – und triggert gezielt den didaktischen Hinweis auf die anatomische Verbindung gemäß aktueller AWMF-Leitlinie.
- 2. **Hypothesenbildung (Clinical Reasoning):** Das System fordert Verbalisierung der Schlussfolgerung. Eine manipulative HWS-Technik ohne Instabilitätsausschluss löst sofort den Safety Guard aus – *Red Flag erkannt.*
- 3. **Bug-Sprint:** Simulation pausiert. Gezieltes Micro-Learning zur Kontraindikation, anschließend Re-Simulation mit leichter Variation. Fehler werden als Lernimpuls verankert, nicht als Versagen gewertet.

Die drei Schichten der Verifizierungsarchitektur

Die Macht liegt im Zusammenspiel von drei Schichten:

- 1. **Input:** Die Studierenden-Aktion/Hypothese.
- 2. **Verarbeitung:** Die KI generiert mögliche Argumentationslinien (KI).
- 3. **Output (Der Safe Guard):** Der Safety Guard vergleicht diese Linien in Echtzeit mit unserer riesigen, geprüften Datenbank des Wissens (Ground Truth) und liefert nur Output, der wissenschaftlich untermauert ist.

Schicht	Funktion
Input	Studierende formuliert Hypothese oder therapeutische Aktion
Verarbeitung	KI generiert Argumentationslinien (xLSTM + Agentic AI)
Output (Safety Guard)	Echtzeit-Abgleich gegen validierte PT-Faktendatenbank (AWMF-Leitlinien, ICF, Fachpublikationen) – nur wissenschaftlich belegter Output erreicht den Lernenden

Das macht Körperfluss zum Digitalen Mentor für die Physiotherapie-Ausbildung – nicht zum Chatbot. Der Unterschied ist fundamental: Ein Chatbot antwortet. Ein Mentor fordert.

KAPITEL 4

Marketing & Vertrieb (Der Verkaufsprozess)

4.1 Strategische Positionierung: Der „Compliance-Hebel“

Körperfluss positioniert sich im DACH-Raum als spezialisierter Lösungsanbieter an der Schnittstelle von **Physiotherapie-Ausbildung** und **digitaler Barrierefreiheit**.

Der primäre Kaufanreiz ist der regulatorische Druck: Das ab 2025 geltende **Barrierefreiheitsstärkungsgesetz (BFSG)**. Wir transformieren rechtliche Risiken (Akkreditierungsverlust, Non-Compliance) in einen digitalen Wettbewerbsvorteil für Bildungsträger.

„Sniper-Marketing“ (Account-Based Marketing)

Da die Zielgruppe mit ca. 300 Institutionen im DACH-Raum klein, aber hochrelevant ist, verzichten wir auf breite Werbemaßnahmen. Unsere Kommunikation fokussiert auf:

- **Targeting:** Direkte Ansprache von strategischen Entscheidungsträgern (Schulleitungen, Studiengangsleitungen und IT-Entscheidern).
- **Botschaft:** Sicherstellung der BFSG-Compliance und Minimierung von institutionellen Haftungsrisiken.

4.2 Vertriebsstrategie: High Touch & Thought Leadership

Aufgrund der Komplexität und der B2B-Zielgruppe erfolgt der Vertrieb durch persönlichen **Direct Sales** und den Aufbau von Branchenautorität.

1. **Thought Leadership:** Publikation von Whitepapers und Fachartikeln zur BFSG-Compliance für Bildungsanbieter sowie Präsenz als Experte auf Branchenkongressen.
2. **Vertrauensbildung (Fachbeirat):** Um die Markteintrittshürden zu senken, binden wir Branchengrößen (geplant: Kooperationen mit Experten wie Herrn Dodel von den Kneipp-Schulen) in einen Fachbeirat ein. Dies sichert die Qualität, dient als Vertrauenssignal noch bevor die Serienreife erreicht ist, und fungiert zudem als strategischer „Türöffner“.
3. **Lead-Generierung:** Direkte, personalisierte Ansprache (Cold Calling / E-Mail) der strategischen Entscheider, gefolgt von individuellen Demos und beratungsintensiven Verkaufsgesprächen (Value Selling).

4.3 Go-to-Market-Strategie: Gezielte Pilotierung zur Skalierung

Wir verfolgen eine klare, risikoarme und dreistufige Markteinführungsstrategie.

Phase 1: Pilot-Akquise & Proof of Concept (Q3/Q4 – Förderphase)

Fokus auf die Gewinnung von **3–5 strategischen Pilotpartnern** (z.B. eine große Fachhochschule und eine spezialisierte Akademie), um eine repräsentative Validierung unterschiedlicher Anwendungsfälle zu gewährleisten.

- **Zielpartner:** Institutionen wie die **FH Linz** oder der **Campus Wien** (gezielte Ansprache für ein gemeinsames Validierungsprojekt).
- **Zielsetzung:** Gemeinsamer Nachweis von KPIs (Key Performance Indicators) wie reduzierte Präsenzstunden für Lehrkräfte und nachgewiesener didaktischer Mehrwert (z.B. messbar schnellere Erfassung von Fallstudien oder höhere Bestehensquoten). Diese Ergebnisse bilden die Basis für unser Referenzmarketing („White-Label Case Study“) und dienen als zentrales Vertriebswerkzeug für die Akquise in Phase 2.

Phase 2: Early Adopter & Verbandspartnerschaften

Erweiterung der Zusammenarbeit über Verbandsconsortien (z.B. Physio Austria, DBfK). Die Akquisition über Fachverbände verleiht uns institutionelle Glaubwürdigkeit und senkt die Vertriebskosten durch das Vertrauen etablierter Netzwerke.

Phase 3: Skalierung & Marktexpansion

Aktiver Export des validierten Ökosystems als Blaupause in den gesamten DACH-Markt (Deutschland/Schweiz). Zu diesem Zeitpunkt werden auch spezialisierte Anbieter für Flächentests des finalen Prototyps relevant.

4.4 Das Erlösmodell: Wertbasiert und Modular

Wir nutzen ein hybrides **B2B-SaaS-Modell**, das dem Bildungsträger erlaubt, gezielt zu skalieren und gleichzeitig die anfängliche Eintrittsbarriere niedrig zu halten (Value Capture-Modell).

Lizenzart	Funktion / Nutzen für den Kunden	Preisrahmen (Basis)	Rolle im Geschäftsmodell
1. Campus-Lizenz	Basis-Setup, Wartung, Support & Compliance-Audit-Report (Der „Schlüssel“).	€ 1.500 – € 4.500 p.a.	Sichert jährliche Basis-Einnahmen (MRR) und ist primärer Kaufanreiz für die IT-Leitung.
2. Sitzplatz-Lizenz	Direkter, skalierbarer Zugang pro aktivem Studierenden-Account (Der Kern).	~€ 12,50 p.M./Account	Der Value-Koppler. Kosten wachsen proportional zum Nutzen; erhöht den Lifetime Value (LTV).

3. Modulare Add-ons	Custom Content Integration, AI-Token, Exam Suite.	Individuell / Usage Fee	Der ARPA-Booster. Verhindert Konkurrenz durch Systemwechsel (sichert Vendor Lock-in).
---------------------	---	-------------------------	---

4.4.1 Kostenbetrachtung: Die Ökonomie pro Studierenden

Um die Kosteneffizienz für den Bildungsträger zu belegen, nutzen wir folgende Beispielrechnung für eine durchschnittliche Fachhochschule (Annahme: 300 aktive Studierende im ersten Jahr):

- **Jährliche Basis-Kosten (Campus-Lizenz):** € 2.250
- **Nutzungskosten pro Student (jährlich):** € 12,50/Monat × 12 Monate = € 150,00 p.a.
- **Gesamtkostensatz pro Studierenden:** € 2.250 (Campus-Lizenz) / 300 Studierende + € 150 (Usage Fee) = **€ 157,50 / Jahr**

Strategisches Fazit: Diese Kosten stehen einem erwarteten ROI von >90% gegenüber: Die Investition von € 157,50 pro Studierenden amortisiert sich bereits durch die Einsparung weniger physischer Simulationsstunden (bei durchschnittlichen Lehrkosten von > € 60/Std.) sowie die Vermeidung potenzieller BfSG-Bußgelder. Körperfluss ist somit keine reine Ausgabe, sondern eine sichernde Investition.

4.5 Implementierungsstrategien: Technologie vs. Skalierung

Wir bieten drei flexible Architekturmodelle an, die dem Budget und den IT-Sicherheitsanforderungen des jeweiligen Kunden entsprechen:

Modell	Ideal für Institutionen	CAPEX (Einmalig)	OPEX (Laufend)	Vorteile (USP)
Cloud-SaaS	Mittlere/Große FHs (Fokus: Skalierung)	Niedrig / Null	Vorhersehbar (€/User)	Sofort verfügbar, automatische Updates. Am schnellsten für den Proof of Concept.
Edge On-Premise	Akademien mit hohem Datenschutzbedarf	Hoch (Server)	Mittel (SLA)	Full Air-Gap: DSGVO-Goldstandard. Daten verlassen das Haus nie.
Hybrid	Großinstitutionen (Uni/FH)	Mittel	Variabel	Bestes aus beiden Welten: Kernlogik lokal (Edge), Skalierung über die Cloud API.

4.6 Differenzierte Preisstruktur nach Institutionstyp (Verkaufskatalog)

Wir passen das Gesamtpaket an das Budget, die Größe und den regulatorischen Fokus des Kunden an:

Tier 1: Universitäten & Große FHs (Enterprise-Kunde)

- **Anforderung:** Hohe Komplexität, riesige Nutzerbasis (>500 Studierende), höchste Anforderungen an Forschung und Datenhoheit.
- **Empfohlenes Modell:** Hybrid (Edge + Cloud).
- **Preismodell:** Maßgeschneidert (Total Cost of Ownership - TCO). Begründung: Große Universitäten tragen hohe initiale CAPEX-Blöcke. Wir verkaufen hier ein vollständiges Ökosystem, kein reines Tool.

Tier 2: Mittelgroße/Spezialisierte FHs & Akademien (Der Kernmarkt)

- **Anforderung:** Gute Skalierung, Fokus auf den akademischen Nachweis und BfSG-Compliance-Proof.
- **Empfohlenes Modell:** Cloud-SaaS (Option auf Edge-Aufschlag +25%).
- **Preismodell (Standardpaket):** Basis-Lizenz ca. € 3.000 p.a. + Studentenlizenz € 12,50/Monat.
- **Zusatz (Strategischer Kaufanreiz):** Einmaliges Compliance-Audit-Report Add-on. Dieser automatisierte Bericht liefert dem Träger den sofortigen Nachweis der gesetzlichen Konformität und dient als starker Hebel für den Vertragsabschluss.

Tier 3: Kleine, Private Bildungseinrichtungen (Startup/Pilotkunden)

- **Anforderung:** Geringe Budgets, Fokus auf spezifische Lehrbereiche (z.B. Osteopathie-Zertifizierung).
- **Empfohlenes Modell:** Cloud-SaaS (Starter-Lizenz).

- **Preismodell (Pay-as-you-go):** Reduzierte initiale Kosten (Campus-Fee ca. € 1.500 p.a.), leicht erhöhte Sitzplatzkosten (€ 18,00/Monat) zur Kompensation der bei kleineren Institutionen fehlenden Skaleneffekte. Vorteil: Erleichtert den Einstieg für Pilotkunden mit dem Ziel des späteren Upscalings.

KAPITEL 5

Unternehmen und Management

(Das Vertrauensverhältnis) Hier zeigen wir, dass das Team nicht nur Ideen hat, sondern die Expertise besitzt, diese auch umzusetzen. Der Mensch hinter der Technologie ist unser größter Wert.

5.1 Gründer-Team und Kompetenzen

Wir stellen ein hochgradig interdisziplinäres Kernteam zusammen, dessen synergetische Wirkung unsere größte Stärke darstellt. Das Wissen von drei verschiedenen Welten (klinisch, technologisch, didaktisch) ist der Grundstein für unseren Erfolg und macht uns immun gegen einzelne Fachkenntnisverluste.

Rolle	Name	Kernkompetenz und Beitrag
Clinical Lead / CEO	Sascha Lagler	Bringt die fachärztliche Glaubwürdigkeit und das Verständnis des realen Bedarfs an den Tisch. Seine Expertise im Clinical Reasoning sichert, dass unser Tool immer auf dem Puls der Zeit ist und direkt in die Praxis adaptiert werden kann.
CTO / Technical Lead	Peter Fischer	Verantwortlich für die gesamte technische Machbarkeit. Er kümmert sich um die Architektur von xLSTM und RAG. Sein Fokus liegt darauf, das System nicht nur möglich, sondern auch massiv skalierbar zu machen.
UX/Didaktik Lead	Lisa Mauerhart	Stellt sicher, dass die komplexeste KI-Technologie in eine nutzerfreundliche, barrierefreie Erfahrung übersetzt wird. Sie sorgt für die Einhaltung des BFSG 2025 und macht das System menschenzentriert.

5.2 Informationen zum Unternehmen (Die rechtliche Grundlage)

Die rechtliche und geographische Struktur des Unternehmens ist auf Agilität, Attraktivität für Talente und Nähe zum Ökosystem der Forschung ausgerichtet.

Kategorie	Beschreibung
Rechtsform	Wir gründen als flexible Rechtsform (Körperfluss Technologies FlexCo) in Wien. Diese Form ist strategisch gewählt, da sie die Agilität eines Startups mit der Rechtssicherheit einer etablierten Gesellschaft kombiniert und uns erlaubt, hochqualifizierte Experten über ESOPs langfristig zu binden.
Gründungsdatum	Date
Sitz	Die Basis im Ökosystem der Wiener Technologieparks (Place) garantiert den ständigen Zugang zu Forschungspartnern (Citation 2).

5.3 Organisationsstruktur (Die Trennung von Forschungs- vs. Geschäftsführung)

Unsere Struktur ist bewusst zweigleisig organisiert, um die Unabhängigkeit der Forschung (FFG) von der Marktorientierung zu gewährleisten.

Arm	Fokus	Zweck
Der R&D-Arm (FFG)	Fokussiert, hochgradig wissenschaftlich, Arbeitspakete 1–4.	Hier arbeiten die Experten an der Technologie, um die Kernentwicklung des Neuro-Symbolischen Filters voranzutreiben.
Der Business-Arm (Kommerzialisierung)	Von Anfang an integriert in das Management.	Stellt sicher, dass jede technologische Entscheidung direkt auf den Marktbedarf (Citation 1) reagiert und damit Fördergelder nicht nur verbraucht, sondern auch wertschöpfend eingesetzt werden.

5.4 Umsetzungsplanung & Strategie (Roadmap)

Der Plan ist linear strukturiert und risikominimierend durch die klare Abfolge von Arbeitspaketen: Wir bauen das System in stabilen Schritten auf (**Meilensteine sind unsere Versicherung**). Die klare Trennung von R&D-Phasen gewährleistet, dass wir nach jedem Meilenstein einen beweisbaren Output vorlegen können.

Zeitraum	Ziel / Meilenstein	Output (TRL)
Kurzfristig (1. Jahr)	Erreichen TRL 4 (Laborgestützte Validierung)	WP 1 (R&D)
Mittelfristig (2. Jahr)	Aufbau der Wien Core Datenbank & Abschluss Curriculum-Mapping	WP 2 (Validierung)
Mittelfristig (3. Jahr)	Erreichen TRL 7 (Validierter Demonstrator im klinischen Einsatz)	WP 3 (Pilotierung)

KAPITEL 6

Erfolgs- und Finanzplanung (Das Herzstück des Antrags)

Die Finanzplanung trennt klar die riskanten Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen (gedeckt durch die FFG-Förderung und Eigenleistungen) von der späteren Kommerzialisierung. Die Zahlen sind durch eine risikominimierende Projektchronologie untermauert, um die wirtschaftliche Machbarkeit in jeder Phase zu gewährleisten.

6.1 Gründungskosten & Gründungsinvestitionen

Da Körperfluss als hochskalierbares Software-Unternehmen (B2B-SaaS) konzipiert ist, fallen die physischen Investitionen (CapEx) äußerst gering aus. Die gesamte Entwicklung erfolgt in einer schlanken, cloudbasierten Umgebung.

- **Gründungskosten:** Diese umfassen die formelle Unternehmensgründung sowie juristische Erstberatungen (B2B-SaaS-Verträge, DSGVO). Diese Kosten werden **außerhalb des FFG-Projektbudgets** direkt aus den privaten Eigenmitteln der Gründer bestritten.
- **Gründungsinvestitionen:** Initiale Hardware-Anschaffungen der Gründer und die grundlegende IT-Infrastruktur sind bereits vorhanden. Zusätzliche Investitionsmittel für Anlagen (Asset Utilization) werden im Rahmen des Förderprojekts nicht benötigt.

6.1.1 Laufende Kosten (F&E-Fokus)

Die laufenden Kosten (OpEx) werden in der Frühphase bewusst schlank gehalten, um die „Burn-Rate“ zu minimieren. Der FFG-Projektantrag ist als reines Software-Entwicklungsprojekt konzipiert, weshalb die Kostenstruktur stark fokussiert ist:

1. **Personalkosten (100 % des FFG-Budgets):** Der mit Abstand größte und zentralste Posten. Er umfasst die Arbeitsstunden des Gründer- und Entwicklungsteams (CTO, Clinical Lead, Design/UX) für die experimentelle F&E-Arbeit.

2. **Materialkosten & Drittkosten (0 % im FFG-Budget):** Laufende Serverkosten, Buchhaltung oder Marketingausgaben werden während der F&E-Phase bewusst aus dem FFG-Kostenplan herausgehalten und über das laufende operative Gründer-Budget getragen, um die Fördermittel zu 100 % in die technologische Wertschöpfung (Personalstunden) zu leiten.

6.1.2 Kapitalbedarf & Finanzierungsquellen (Kosten- und Finanzierungsübersicht)

Der gesamte Kapitalbedarf für die Entwicklung der Neuro-Symbolischen Middleware und der Safety Guard-Architektur bis zur Marktreife (TRL 7) wird auf **130.800 €** kalkuliert. Die folgende Kostenstruktur entspricht exakt der im eCall eingereichten Struktur und ist in fünf Arbeitspakete (AP) gegliedert.

Kostenübersicht nach Arbeitspaketen (in €)

Kostenkategorie	AP 1 (PM)	AP 2 (Architektur)	AP 3 (Dialog)	AP 4 (Compliance)	AP 5 (Integration)	Total
Personalkosten	10.800,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	130.800,00
Sachkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Drittkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	10.800,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	130.800,00

(Hinweis: Das Projekt wird durch interne Team-Ressourcen umgesetzt. Der kalkulierte Gemeinkostenzuschlag (GKZ) von 20 % auf die Personalkosten deckt die pauschalen betrieblichen Nebenkosten ab).

Detaillierte Kostenaufschlüsselung (Personal)

Name / Funktion	Stunden	€/h (inkl. 20% GKZ)	Plankosten (€)
Peter Fischer / CTO, tech. Entwicklung	1.120	60,00	67.200,00
Sascha Lagler / Clinical Lead	900	60,00	54.000,00
Lisa Mauerhart / Design & UX	160	60,00	9.600,00
Total Personalkosten	2.180		130.800,00

Finanzierungsstruktur (Funding)

Finanzierungsart	Betrag (€)	% der Kosten	Zweck im Projekt
FFG-Förderung (Zuschuss)	58.860,00	45,00 %	Direkte F&E-Kosten (anteilige Personalkosten).
Eigenmittel (Basis)	39.240,00	30,00 %	Puffer für operative Liquidität, Sicherstellung der Eigenmittelquote.

Erweiterte Eigenmittel	32.700,00	25,00 %	Restfinanzierung des Projekts. Abgesichert durch Wasserfall-Modell.
------------------------	-----------	---------	---

Die Sicherungsstrategie für den Eigenanteil (Wasserfall-Prinzip)

Um die Gesamtfinanzierung von 130.800 € bestmöglich zu garantieren und das Risiko für den Fördergeber zu minimieren, wird der notwendige Eigenanteil von insgesamt 71.940 € durch eine risiko abgesicherte, dreistufige Strategie gedeckt:

1. **Plan A: Vorab-Umsätze durch Pilotpartner (Co-Development):** Aufgrund des konkreten Interesses erster Institutionen (wie der FH Linz) streben wir in der Frühphase „Early-Bird“-Lizenzierungen an. Pilotpartner können sich finanziell beteiligen, um die Lösung frühzeitig auf ihre Curricula anzupassen. (Partner wie die Kneipp-Schulen werden in einer späteren Phase relevant, sobald der Prototyp für Tests bereitsteht).
2. **Plan B: Strategische Investoren (Smart Money):** Wir bereiten parallel die gezielte Ansprache von Business Angels vor, die neben dem Kapital vor allem wertvolle Netzwerke im Gesundheitssektor mitbringen.
3. **Plan C: Das Sicherheitsnetz (Private Besicherung):** Sollten Pilot-Umsätze oder Investorengelder zeitlich verzögert eintreffen, garantieren die Gründer die lückenlose Abdeckung. Der gesamte verbleibende Finanzierungsbedarf (die kompletten 71.940 € aus Basis- und erweiterten Eigenmitteln) wird durch verbindliche Gesellschafterzuschüsse aus privaten Rücklagen (insb. durch den Hauptgesellschafter Sascha Lagler) zwischenfinanziert. Dies ist formal durch die Bereitschaft zur Abgabe einer Patronatserklärung/Finanzierungszusage untermauert.

ALTERNATIVE FINANZIERUNGSOPTION

Variante B: Co-Founder-Modell „Lisa Mauerhart“ (26 % Anteil)

Strukturelle Schließung des Eigenmittel-Gaps via SMS-Gründungsbeihilfe + FFG-Inklusionsbonus

BLUF: Die Einbindung von Lisa Mauerhart als geschäftsführende Gesellschafterin mit **26 % Anteilen** schließt das verbleibende Liquiditäts-Gap von **33.940 €** punktgenau durch die SMS-Gründungsbeihilfe (max. 34.400 €) und sichert zusätzlich den FFG-Inklusionsbonus (SDG 10).

Strukturvergleich: Option A (Bestand) vs. Option B (Lisa als Co-Founder)

OPTION A · Wasserfall-Modell

Sascha Lagler als Hauptgesellschafter

- FFG-Förderung: 58.860 € (45 %)
- Eigenmittel Sascha Lagler : 71.940 € (55 %)
- Absicherung: Pilot-Umsätze → Angels → Patronatserklärung
- **Risiko:** Hohe Eigenmittelbelastung, Abhängigkeit vom Hauptgesellschafter

OPTION B · Co-Founder Lisa Mauerhart

Erweiterte Gesellschafterstruktur

- FFG-Förderung: 58.860 € (45 %) + Inklusionsbonus
- Eigenmittel Sascha Lagler: 38.000 € (29 %)
- SMS-Gründungsbeihilfe Lisa Mauerhart: 33.940 € (26 %)
- **Vorteil:** Cash-Gap geschlossen, Social-Impact-Profil, OpEx-Ersparnis

Förder-Landscape – Fokus Option B

Förderpartner	Programm	Fördergegenstand	Art	Max EUR	Quote %	Begründung
SMS	Startförderung	Gründungskosten Lisa Mauerhart	Zuschuss	34.400	50	Legitimiert den Cash-Gap von 33,9 k EUR.

FFG	Kleinprojekt	F&E Körperfluss EDU	Zuschuss	58.860	45	sichert Impact-Rating in SDG 10.
Finanzamt	LNK-Befreiung	Lohnnebenkosten	Befreiung	–	~7,1	Ersparnis bei DB, DZ, KommSt

Cash-Gap-Analyse Option B (Punktgenaue Schließung)

Position	Betrag (€)	Anteil	Quelle
Gesamtkosten Projekt	130.800	100,0 %	FFG-Kostenplan
./. FFG-Förderung (Zuschuss)	-58.860	-45,0 %	FFG Kleinprojekt
./. Eigenmittel Sascha Lagler	-38.000	-29,1 %	Privat / Sweat Equity
= Liquiditäts-Gap	33.940	25,9 %	Zu schließen
./. SMS-Startförderung Lisa Mauerhart	-33.940	-25,9 %	SMS (max. 34.400)
= Restbedarf	0	0,0 %	Vollfinanziert

Abhandlungsplan: Integration Lisa Mauerhart

Step	Phase	Aufgabe	Zuständig	Fällig	Output-Dokument
1.0	Setup	GdB-Bescheid für Lisa finalisieren (Basis: Gutachten Billeth)	Lisa Mauerhart	Sofort	Bescheid SMS
1.1	Ops	Lisa im FFG-Vollantrag auf 26 % heben	Sascha Lagler	26.04.	eCall-Systemupdate
1.2	Funding	SMS-Startförderungsantrag für Lisa stellen	Sascha Lagler	Vor Notar	Antragsbestätigung
1.3	Legal	GesV mit 26 % & Weisungsfreiheit für Lisa	Notar	Mai	Gesellschaftsvertrag

Frage & Antwort (Beweisführung)

Frage zur Legitimation	Strategische Antwort & Beweis
Wie wird die Finanzierungslücke geschlossen?	Bedarf: 130,8 k € (Kosten) – 58,8 k € (FFG) – 38 k € (Sascha) = 33.940 € Gap . Lisas SMS-Zuschuss (max. 100 × Ausgleichstaxe à 344 € in 2026) deckt bis zu 34.400 €. Damit ist das Projekt gegenüber der FFG vollfinanziert.

Warum benötigt Lisa Mauerhart exakt 26 % Gesellschaftsanteile?	Das SMS fördert nur „Inhaber“. Rechtlich gilt eine Person erst ab einer Beteiligung von über 25 % als wirtschaftlich selbstständig (GSVG-Pflicht), was die zwingende Basis für die Gründungsbeihilfe ist.
Was beweist das Gutachten Dr. Billeth für die Einreichung?	Es belegt Lisas dauerhafte Erwerbsunfähigkeit seit 10/2021. Dies legitimiert den massiven Social Impact (SDG 10) bei der FFG und begründet die „Rehabilitation durch Selbstständigkeit“ beim SMS.
Wann muss Lisa Mauerhart offiziell in den Businessplan?	Sofort. Für die FFG-Deadline am 27.04. muss sie als „Design-Lead & Co-Founder“ mit 26 % Anteil aufscheinen. Der rechtliche Vollzug (Notar) folgt erst nach der SMS-Antragstellung im Mai.
Welche operativen Fixkosten (OpEx) spart diese Option ?	Für Lisa entfallen dauerhaft der Dienstgeberbeitrag (3,7 %), der DZ (~0,33 %) und die Kommunalsteuer (3,0 %). Dies senkt die Personalkostenbelastung des Startups um ca. 7,1 % ihrer Bruttobezüge.

Modifizierte Finanzierungsstruktur (Option B)

Finanzierungsart	Betrag (€)	% der Kosten	Zweck im Projekt
FFG-Förderung (Zuschuss)	58.860,00	45,00 %	Direkte F&E-Kosten + Inklusionsbonus (SDG 10).
Eigenmittel Sascha Lagler	38.000,00	29,10 %	Operative Liquidität, Hauptgesellschafter-Anteil.
SMS-Startförderung (Lisa Mauerhart , 26 %)	33.940,00	25,90 %	Schließt Cash-Gap punktgenau, sichert Inhaberstatus.
Total	130.800,00	100,00 %	Vollfinanziert ohne Patronatserklärung.

Hinweis: Option A (Wasserfall-Prinzip) und Option B (Co-Founder Lisa) stehen alternativ zueinander. Die finale Entscheidung erfolgt nach Vorliegen der unter „Noch ausstehend“ genannten Dokumente.

6.1.3 Planbilanz und Plan-Gewinn-und Verlustrechnung (GuV)

Die Plan-GuV spiegelt die typische Kurve eines hochskalierbaren Software-Startups wider:

- **Jahr 1:** Geplantes negatives Betriebsergebnis. Es fallen hohe Entwicklungskosten an (abgebildet in den Personalkosten), denen noch keine Umsatzerlöse gegenüberstehen. Dieser Liquiditätsabfluss wird durch die FFG-Zuschüsse und Eigenmittel abgedeckt. Buchhalterisch wird der Aufbau der Software in der Planbilanz über die Aktivierung von Eigenleistungen (gemäß UGB) abgebildet, um eine rechnerische Überschuldung zu vermeiden.
- **Jahr 2:** Erste Umsatzerlöse (MRR) aus vergünstigten Pilot-Lizenzen werden verbucht. Das Ergebnis bleibt leicht negativ, da weiterhin in Systemintegration und Roll-out investiert wird.
- **Jahr 3:** Skalierungseffekte treten ein. Da die F&E-Phase abgeschlossen ist, steigen die laufenden Kosten nur marginal an, während die Umsätze durch neue Kunden exponentiell wachsen. Das Erreichen der operativen Gewinnschwelle (Break-Even-Point auf Cashflow-Basis) ist präzise für das Ende des dritten Jahres fest eingeplant.

6.2 Derzeitige Finanzierung und Organisation des Rechnungswesens

Derzeitige Finanzierung: Die Vorbereitungsphase und das bisherige Konzeptdesign wurden vollständig aus Eigenmitteln bestritten (primär „Sweat Equity“ sowie die Nutzung privater Rücklagen für Infrastruktur und Lizenzen).

Organisation des Rechnungswesens: Da bei FFG-geförderten Projekten höchste Transparenz gefordert ist, wird das Rechnungswesen professionell und richtlinienkonform aufgestellt:

- 1. **Externe Steuerberatung:** Laufende Finanzbuchhaltung und Bilanzerstellung werden an eine externe Kanzlei ausgelagert (finanziert aus den nicht-geförderten Eigenmitteln).
- 2. **FFG-konforme Abrechnung:** Es wird ein digitales, cloudbasiertes Kostenrechnungssystem etabliert, das auf lückenlosen, projektbezogenen Zeitaufzeichnungen basiert (strikt nach dem aktuellen *FFG-Kostenleitfaden*). Da 100 % der Projektkosten auf Personalkosten entfallen, ist eine exakte, stundengenaue Dokumentation der F&E-Tätigkeiten von Peter, Sascha und Lisa gewährleistet.
- 3. **Liquiditätssteuerung:** Agiles Liquiditäts-Dashboard zur Überwachung der monatlichen Burn-Rate, des Eingangs von Förderraten (Akonto-Zahlungen) und zur Sicherstellung der Auszahlungsfähigkeit der kalkulierten Gehälter.

KAPITEL 7

SWOT-Analyse (Die Selbstkritik)

Dieser Abschnitt zeigt nicht nur die Alleinstellungsmerkmale von Körperfluss, sondern auch eine realistische Einschätzung der internen Schwächen und externen Risiken. Dies beweist die Glaubwürdigkeit und Reife des Projekts für die FFG-Förderung.

Überblick: Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken

Kategorie	Befund / Analysepunkt
STÄRKEN (S)	MDR-Freiheit (juristisch abgesichert); Evidenzbasis durch den Safety Guard (eliminiert Halluzinationen); Gründerteam mit dreifachem Know-how (Klinik + Tech + Didaktik); Lokale Datenhoheit (Edge-Computing) erfüllt EU-Standards.
SCHWÄCHEN (W)	Kleines Team (hohe Abhängigkeit von Schlüsselpersonen); Anfängliche Abhängigkeit von der FFG-Förderzusage; Hohe initiale F&E-Komplexität (xLSTM).
CHANCEN (O)	Gesetzlicher Zwang zur Digitalisierung/Barrierefreiheit (BFSG 2025); Massives Wachstum des EdTech/Digital Health Marktes; Skalierbarkeit in universelle Domänen (Jura, Ingenieurwesen) durch „Global-to-Local“-Design.
RISIKEN (T)	Mögliche Fehleinstufung als Medizinprodukt (MDR-Risiko); Nicht-Zusage der FFG-Förderung; Technologische Komplexität bei der Skalierung des xLSTM-Modells.

Detaillierte Bewertung und Strategische Antwort

Kategorie	Analysepunkt	Im Pitch verwenden (Die Strategische Antwort)
STÄRKE N (S)	Technologische und juristische Differenzierung.	Wir sind technologisch unschlagbar in unserer Nische der sicheren, evidenzbasierten KI-Anwendung. Der Safety Guard macht den Output juristisch belastbar.

SCHWÄCHEN (W)	Teamgröße und Bürokratie.	Das kleine, hochspezialisierte Gründerteam ist ein Vorteil: Es garantiert höchste Flexibilität, schnelle Entscheidungsfindung (Agile Entwicklung) und minimiert Bürokratie. Wir steuern das Risiko durch die klare WP-Aufteilung .
CHANCEN (O)	Regulatorischer Markt-Pull.	Die gesetzlichen Vorgaben des Staates (BFSG 2025) erzeugen eine Marktlücke, die nur unsere Lösung füllt. Wir reagieren auf einen zwingenden Markt-Pull , nicht nur auf einen Bedarf.
RISIKEN (T)	Gefahr der Fehleinstufung / Förderausfall.	Wir begegnen dem Risiko proaktiv: Durch den strikten „ Education-Only “-Fokus und die MDR-Freiheit minimieren wir das Haftungsrisiko. Die klare WP-Aufteilung garantiert, dass das Projekt auch bei einer Teilfinanzierung strukturiert weitergeführt werden kann.

Fazit: Glaubwürdigkeit und Reife

Die SWOT-Analyse bestätigt, dass die Stärken von Körperfluss (MDR-Freiheit, Safety Guard, Datenhoheit) direkt auf die größten externen Chancen (BFSG 2025) einzahlen und die relevanten Risiken proaktiv durch die Architektur (Education-Only) gemindert werden. Das Projekt ist somit nicht nur innovativ, sondern auch **strategisch und finanziell abgesichert**.